

Ambulantní zpráva

Pasztorek Stanislav

Dat. nar.: 17.7.1983

Ze dne: 27.8.2026 11:01

Č. poj.: 8307175844

Bydliště: Křhová 441, VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ 75701

Kód poj.: 213

RA: matka - hypertenze, otec - zemřel nedávno

OA: - Arteriální hypertenze

- Chron. toxonutritivní hepatopatie, chron. absusu alkoholu

AA: Alergie: Pacient(ka) neudává alergie

FA: Citalec 10mg tbl. 1-0-0, Prednison 30mg tbl. 1-0-0, Essentiale F 600mg tbl. 1-1-1, Thiamin 50mg tbl. 1-1-1, Ursosan F 500mg tbl. 1-0-0, B-komplex tbl. 1-0-0

EA: negativní,

Návyk: Kouření: nekouří od r. 2013

Alkohol: naposledy 18.7.2026, od té doby abstinuje

Návyk. látky: v mládí občas tvrdé drogy, nyní dlouho nic

tč. nezaměstnaný, stará se o manželku, která má epilepsii

Kontrola po hospitalizaci, hospit. pro akutní OH hepatitidu, příznivý průběh, nasazený kortikoidy po vyloučení kontraindikací, responder, klinicky i laboratorně zlepšen.

Subj. po propuštění se cítí lépe, je slabý, unavený. Nepije. Alkohol mu nyní smrdí. Měl problém se suchostí v ústech večer, snížil si o 1/2 tbl. dávku prednisonu, poté se mírně ulevilo. Zhubnul. Ještě mírně hubne, zejména svaly, poznal na chůzi a slabosti dolních končetin. Má motivaci abstinovat, vrátí mu děti, bude bydlet v azyl. domě v Novém Jičíně

Laboratorně je nyní při kontrole při dimisi pokles bilirubínu, pokles JT, přetrv. izol. elev. GGT, KO se normalizuje, koagulace v normě.

Objektivní nález: Hmotnost [kg]: 70, Výška [cm]: 179, BMI: 21.85, Plocha těla [m²]: 1.88

Status praesens: Pacient je při vědomí, lucidní, orientován je všemi směry, chodící, normostenik, anikterický, hlava poklepově neolestivá, ameningeální, zornice izokorické, akce srdeční klidná, pravidelná, bez šelestu, dýchání skřípkové, čisté, bez vedlejších fenoménů, břicho palpačně měkké, prohmatné, bez hmatné rezistence, peristaltika slyšitelná, DKK bez otoků

UZ břicho, 25.7.2026 16:43, RDG SONO 2, MUDr. Barbora Klvaňová

Provedená vyšetření:

Závěr:

Mírná hepatomegalie, hepatopatie s ojed. hypoechogenními okrsky, stac. zesílená stěna žlučníku - v.s. v rámci hepatopatie.

Základní biochemie:

S_UREA: 4,9 mmol/l [2.1 ... 7.1], S_CREA: 87 μmol/l [59 ... 104], PT(KIDN)_CLOCREA: 1,47 ml/s [1 ... 1.5], PT(KIDN)_EGFRCKDE: > 1,50 ml/s/1,73 m² [1 ... 1.5], S_NA: 138,0 mmol/l [136 ... 145], S_K: 4,16 mmol/l [3.5 ... 5.1], S_CL: 99,6 mmol/l [98 ... 107], S_BIL: 34,5 μmol/l [0 ... 21], S_BILCON: 30,5 μmol/l [0 ... 5], S_ALT: 1,25 μkat/l [0.17 ... 0.83], S_AST: 0,81 μkat/l [0.17 ... 0.85], S_GGT: 8,17 μkat/l [0.17 ... 1.19], S_ALP: 1,68 μkat/l [0.67 ... 2.15], S_GLC: 4,3 mmol/l [3.5 ... 5.6]

Hemokoagulace:

P_PT: 91,0 % [80 ... 120], P_PTR: 1,04 l [0.8 ... 1.2], P_INR: 1,05 l [0.8 ... 1.2], P_APTT: 26,7 s [26.4 ... 37.5], P_APTTR: 0,86 l [0.8 ... 1.2]

Krevní obraz a DIF:

B_LKC: 13,15 10⁹/l [4 ... 10], B_ERC: 3,91 10¹²/l [4 ... 5.8], B_HB: 129 g/l [135 ... 175], B_HCT: 0,382 l [0.4 ... 0.5], ERC(B)_MCV: 97,7 fl [82 ... 98], ERC(B)_MCH: 33,0 pg [28 ... 34], ERC(B)_MCHC: 338 g/l [320 ... 360], ERC(B)_RDW: 0,166 l [0.1 ... 0.152], B_PLT: 269 10⁹/l [150 ... 400], PLT(B)_MPV: 9,7 fl [7.8 ... 11], 10⁹/l [0.8 ... 4], B_MONO: 0,88 10⁹/l [0.08 ... 1.2], B_LYMF: 2,41

0.5], B_BAS: 0,05 10⁹/l [0 ... 0.2], LKC(B)_NEU: 0,720 l [0.45 ... 0.7], LKC(B)_LYMFO: 0,183 l [0.2 ... 0.45], LKC(B)_MONO: 0,067 l [0.02 ... 0.1], LKC(B)_EOS: 0,026 l [0 ... 0.05], LKC(B)_BAS: 0,004 l [0 ... 0.02], PLT(B)_PDWSD: 11,2 fl [10 ... 17]

Diagnózy:

Ambulantní zpráva

Dat. nar.: 17.7.1983

Ze dne: 27.8.2026 11:01

Č. poj.: 8307175844

Kód poj.: 213

Pasztorek Stanislav
Bydliště: Křehová 441, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 75701

RA: matka - hypertenze, otec - zeměl nedávno

OA: - Arteriální hypertenze

- Chron. toxonutritivní hepatopatie, chron. absusu alkoholu

AA: Alergie: Pacient(ka) neudává alergie

FA: Citalac 10mg tbl. 1-0-0, Prednison 30mg tbl. 1-0-0, Essentiale F 600mg tbl. 1-1-1, Thiamin 50mg tbl. 1-1-1, Ursosan F 500mg tbl. 1-0-0, B-komplex tbl. 1-0-0

EA: negativní,

Návyk: Kouření: nekouří od r. 2013

Alkohol: naposledy 18.7.2026, od té doby abstinguje

Návyk. látky: v mládí občas tvrdé drogy, nyní dlouho nic
tč. nezaměstnaný, stará se o manželku, která má epilepsii

Kontrola po hospitalizaci, hospit. pro akutní OH hepatitidu, příznivý průběh,
nasazený kortikoidy po vyloučení kontraindikací, responder, klinicky i laboratorně
zlepšen.

Subj. po propuštění se cítí lépe, je slabý, unavený. Nepije. Alkohol mu nyní smrdí.
Měl problém se suchostí v ústech večer, snížil si o 1/2 tbl. dávku prednisonu, poté
se mírně ulevilo. Zhubnul. ještě mírně hubne, zejména svaly, poznal na chůzi a
slabosti dolních končetin. Má motivaci abstinovat, vrátí mu děti, bude bydlet v
azyl. domě v Novém Jičíně

Laboratorně je nyní při kontrole při dimisi pokles bilirubínu, pokles JT, přetrv.
isol. elev. GGT, KO se normalizuje, koagulace v normě.

Objektivní nález: Hmotnost [kg]: 70, Výška [cm]: 179, BMI: 21.85, Plocha těla [m2]: 1.88

Status praesens: Pacient je při vědomí, lucidní, orientován je všemi směry, chodící, normostenik,
anakterický, hlava poklepově nebolestivá, ameningeální, zornice izokorické, akce
srdeční klidná, pravidelná, bez šelestu, dýchání skřípkové, čisté, bez vedlejších
fenoménů, břicho palpačně měkké, prohnatné, bez hmatné rezistence, peristaltika
slyšitelná, DKK bez otoků

UZ břicho, 25.7.2026 16:43, RDG SONO 2, MUDr. Barbora Klvaňová

**Provedená
vyšetření:**

Závěr:

Mírná hepatomegalie, hepatopatie s ojed. hypoechogenními okrsky, stac. zesílená
stěna žlučníku - v.s. v rámci hepatopatie.

Základní biochemie:

S_UREA: 4,9 mmol/l [2.1 ... 7.1], S_CREA: 87 µmol/l [59 ... 104], PT(KIDN)_CLOCREA:
1,47 ml/s [1 ... 1.5], PT(KIDN)_EGFRCKDE: > 1,50 ml/s/1,73 m2 [1 ... 1.5], S_NA:
138,0 mmol/l [136 ... 145], S_K: 4,16 mmol/l [3.5 ... 5.1], S_CL: 99,6 mmol/l [98
... 107], S_BIL: 34,5 µmol/l [0 ... 21], S_BILCON: 30,5 µmol/l [0 ... 5], S_ALT:
1,25 µkat/l [0.17 ... 0.83], S_AST: 0,81 µkat/l [0.17 ... 0.85], S_GGT: 8,17 µkat/l
[0.17 ... 1.19], S_ALP: 1,68 µkat/l [0.67 ... 2.15], S_GLC: 4,3 mmol/l [3.5 ...
5.6]

Hemokoagulace:

P_PT: 91,0 s [80 ... 120], P_PTR: 1,04 l [0.8 ... 1.2], P_INR: 1,05 l [0.8 ...
1.2], P_APTT: 26,7 s [26.4 ... 37.5], P_APTTR: 0,86 l [0.8 ... 1.2]

Krevní obraz a DIFF:

B_LKC: 13,15 10⁹/l [4 ... 10], B_ERC: 3,91 10¹²/l [4 ... 5.8], B_HB: 129 g/l [135
... 175], B_HCT: 0,382 l [0.4 ... 0.5], ERC(B)_MCV: 97,7 fl [82 ... 98], ERC(B)
_MCH: 33,0 pg [28 ... 34], ERC(B)_MCHC: 338 g/l [320 ... 360], ERC(B)_RDW: 0,166 l
[0.1 ... 0.152], B_PLT: 269 10⁹/l [150 ... 400], PLT(B)_MPV: 9,7 fl [7.8 ... 11],
B_PCT: 2,600 10⁻³ [1.2 ... 3.5], B_NEU: 9,47 10⁹/l [2 ... 7], B_LYMF: 2,41
10⁹/l [0.8 ... 4], B_MONO: 0,88 10⁹/l [0.08 ... 1.2], B_EOS: 0,34 10⁹/l [0 ...
0.5], B_BAS: 0,05 10⁹/l [0 ... 0.2], LKC(B)_NEU: 0,720 l [0.45 ... 0.7], LKC(B)
_LYMFO: 0,183 l [0.2 ... 0.45], LKC(B)_MONO: 0,067 l [0.02 ... 0.1], LKC(B)_EOS:
0,026 l [0 ... 0.05], LKC(B)_BAS: 0,004 l [0 ... 0.02], PLT(B)_PDWSD: 11,2 fl [9
... 17]

Diagnózy:

K701

Alkoholický zánět jater (akutní hepatitida)

Vytvářeno dne: 27 srpna 2026

Tisk provedl(a): MUDr. Martin Šplíšek

Ambulantní zpráva

Pasztorek Stanislav

Dat. nar.: 17.7.1983 Kód poj.: 213

Č. poj.: 8307175844

Závěr:

Stp. akutní alkoholové hepatitidy 07/2026

- zlepšeno na kortikoterapii, pozit. responder

* Medikace - snižovat dávku Prednisonu do vysazení - dle následujícího schématu,

snižování dávky co 1 týden, 20mg/týden, 15mg/týden, 10mg/týden, 5mg/týden a vysadit
* Dále v medikaci pokračovat Citalac 10mg tbl. 1-0-0, Essentiale F 500mg tbl. 1-1-1,

1, Ursosan F 500mg gtbl. 1-0-0 a B-komplex tbl. 1x denně

* Doporučuji současně psychologickou event. psychiatrickou péči, nejlépe i

adiktologickou, žádanka vydána

* Dieta - dūraz na dietní, pravidelnou stravu, nyní omezení příjmu tuku - jíst

častěji (5-6x denně), po menších porcích, energeticky hodnotné potraviny s vysokým
obsahem kvalitních bílkovin - ryby, vejce, luštěniny, soju, maso - drůbeží či

libové hovězí. Přílohy např. rýže, brambory, batáty, zelenina apod.

Šetřící úprava jídla (nesmažit, nedráždivá úprava; dochucovat bylinkami).

Do jídla i pítí lze přimíchávat Protifar, Resource instant protein, Fresubin

Protein Powder - bílkovina v prášku - volně prodejně

* Alkoholová abstinence nadále včetně nealkoholového piva

* Naše kontrola v GE poradně za 1 měsíc, s kontrolními krevními odběry 2-3 dny

předem (KO+diff, CRP, Na, K, Cl, urea, kreat, CKD-EPI, JT, bill, INR, Q, aptt, albumin, celk.

bilk, Ferritin)

Pacient byl seznámen se svým zdravotním stavem, s navrženým způsobem léčby, všemu

rozumí a s ošetřením souhlasí.

Výkony: 15022(1x)

Vykázáno ZP:

Dne: 27.8.2026 11:33

MUDr. Martin Špišek

94	Nemocnice AGE	Valašské Meziříčí a.s.
102	Gastroenterologická ambulance	U Nemocnice 980
829	757 01 Valašské Meziříčí	Tel. 571 758 244